UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ - UNIVALI
Curso: Arquitetura e Urbanismo
Disciplina: Trabalho Final de Graduação I
Professores: Stavros Wrobel Abib e Carolina Carvalho

ENSAIO CONCEITUAL

CENTRO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA SAÚDE MENTAL

INTRODUÇÃO

O Trabalho Final de graduação propõe um projeto de um Centro de Saúde Mental, voltado à prevenção e o tratamento de pacientes diagnósticas com transtorno depressivos e transtorno de Ansiedade. A proposta busca investigar e aplicar o papel da arquitetura como agente co-terapêutico desde os sintomas iniciais, atuando com espaços que favorecem o bem-estar, amenizando o estresse e fadiga mental. Incorporando diretrizes com a integração dos elementos naturais (iluminação, ventilação e conexão com a natureza) equilibrando espaços que favorecem a integração social e privada dos usuários, além de ambientes voltados a terapias individuais, coletivas e oficina terapêuticas.

O tema se tornou relevante diante o cenário global atual, segundo a OMS (2025), cerca de 1 a cada oito pessoas no mundo é diagnóstica com alguém transtorno mental, destaca alerta e estima que até 2030 metade da polução mundial sofra com doenças psicossomáticas. No contexto brasileiro, embora implementados serviços públicos de saúde mental abertos à comunidade, como a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e ao Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), atuando dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), a crescente demanda por acolhimento evidencia a necessidade de novos equipamentos capazes de favorecer eficiência nos atendimentos prestados e espaços humanizados.

JUSTIFICATIVA

Nos últimos anos, o assunto da saúde mental ganhou destaque em virtude dos avanços da tecnologia e meios de comunicação digital. A depressão e a ansiedade resultam de uma interação complexa de fatores sociais, psicológicos e biológicos,

afetando a saúde física, mental e social (OMS, 2026). No Brasil, isso se reflete em índices alarmantes: conforme aponta o Ministério da Saúde (2025), estima-se que cerca de 15% da população sofre de depressão; e, segundo o Ministério do Trabalho (2025), os afastamentos por transtornos mentais registraram um aumento de 197,7% entre 2021 e 2025, totalizando 559.983 concessões de benefício, liderados por transtornos ansiosos e depressivos.

Apesar de a expansão da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) ter atingido a marca de 3.019 CAPS em 2024 (DESMAD, 2024), o psiquiatra Barros (2025) aponta que, após a pandemia mundial, a demanda reprimida se intensificou na busca por atendimentos, o que superlotou os consultórios e sobrecarregou os serviços públicos de saúde mental. Entretanto, estudos apontam que os serviços de saúde mental ainda têm dificuldades relacionadas à infraestrutura física (Souza; Pereira, 2023) e à adequação dos ambientes para atividades terapêuticas (SILVA et al., 2023). A inadequação dos espaços físicos pode comprometer a qualidade dos atendimentos, prejudicando o acolhimento e a integração dos usuários em atividades coletivas. Diante desse cenário, evidencia-se que o ambiente construído desempenha um papel fundamental na percepção do bem-estar. Segundo a arquiteta Melaine Tinhof, estudos demonstram que o espaço físico afeta o funcionamento do corpo, atuando a favor ou contra a saúde humana e interferindo nos estados emocionais. Em outras palavras, o espaço fala diretamente com o sistema nervoso, trazendo sentimentos positivos ou negativos.

OBJETIVOS

Projetar um Centro de Saúde Mental voltado à prevenção e tratamento dos transtornos de depressão e ansiedade.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Criar espaços que favoreçam a redução do estresse e promoção do bem-estar;
- Propor espaços funcionais para convivência social e privacidade do usuário;
- Incorporar elementos naturais para a melhoria da qualidade de vida do usuário.

RECORTE DE REVISÃO DE LITERATURA

A Organização Mundial da Saúde (OMS,2025) aponta que, a depressão e ansiedade são principais causas de incapacidade produtiva no mundo. Segundo o autor Alan (2014) as doenças estão se tornando mais de natureza psicossocial e psicossomática na sociedade atual. A forma de como vivemos, trabalhamos e interagimos com o **ambiente construído** têm um impacto enorme em nossas emoções e experiências.

Diante disso, os ambientes também afetam o comportamento, mas de maneira limitada. A arquitetura não pode ser vista como um meio modificador do comportamento humano, a ponto de transformar a personalidade de indivíduos, mas pode influenciar a percepção e cognição de espaços e com isto proporciona a satisfação do uso. (KOWALTOWSKI, et al. 2017).

Segundo o arquiteto Ákos Orbán, ambientes construídos moldam continuamente como as pessoas percebem, agem, sentem e dão sentido ao espaço, revelando como as características ambientais envolvem processos perceptivos, cognitivos e afetivos. Segundo a abordagem de Ulrich et al. (1991), as experiências de ambientes físicos, visualmente prazerosos, podem auxiliar na redução do estresse, uma vez que desencadeiam emoções positivas, mantêm o estado de atenção não vigilante, diminuem os pensamentos negativos e possibilitam o retorno à excitação fisiológica (physiological arousal) para níveis mais moderados.

No entanto, esse conhecimento permanece disperso por diferentes campos e níveis de análise, sem uma estrutura compartilhada que o conecte ao raciocínio arquitetônico e à prática de design (ORBÁN; VESSEL, 2026). Entende-se, portanto, que as reações de conforto fisiológico estão associadas às reações de conforto psicológico e ao sentimento de bem-estar no local. Um ambiente bem projetado pode, assim, influenciar o modo de vida das pessoas e favorecer o seu bem-estar, priorizando aspectos de conforto, funcionalidade, economia e estética, por meio da aplicação de conhecimentos artísticos, técnicos e de psicologia ambiental (AZEVEDO; MURILHA, 2023).

CONCEITOS

O Conceito de **Design Salulogênico**, inspirada na teoria do estresse de Aaron Antonovsky, tem premissa em buscar identificar os fatores do bem-estar (wellness factors) e incorporar estímulos psicossociais positivos no ambiente construído. O Autor Alan Dilani interpreta e propõe uma abordagem arquitetônica e teórica que sugerem uma mudança de paradigma em relação ao modelo médico tradicional, ele busca a utilização de elementos como iluminação natural, contato com a natureza, arte, controle ambiental e áreas de suporte social, buscando fortalecer o senso de coerência dos indivíduos, tornando espaços compreensíveis, gerenciáveis e significativos para reduzir a ansiedade e promover estados emocionais saudáveis. O conceito atua como estratégia para cuidados preventivos, incentivando comportamentos saudáveis, a fim de combater as doenças não transmissíveis. Além de atuar na criação de espaços para a prevenção de enfermidades psicossocial, tornando ambientes que estimulem a inovação social, elevando a produtividade e melhora a qualidade de vida coletiva.

O conceito de **espaços relacionais** atua na criação de espaços que equilibram a convivência social e a individualidade. Vinculando áreas coletivas com zonas privadas, que evitem a sobrecarga social ao tornar a interação uma escolha. Também utiliza a combinação dos elementos para atuar no bem-estar, ambientes de conforto ambiental, com adequação de luz, ventilação, acolhimento e flexibilidade do espaço que atenda às necessidades dos usuários, a fim de promover áreas de estudos, lazer, descanso e serviços. Reforça o sentimento de pertencimento e amplia a motivação de permanência. (WORSLEY; HARRISON; CORCORAN, 2023).

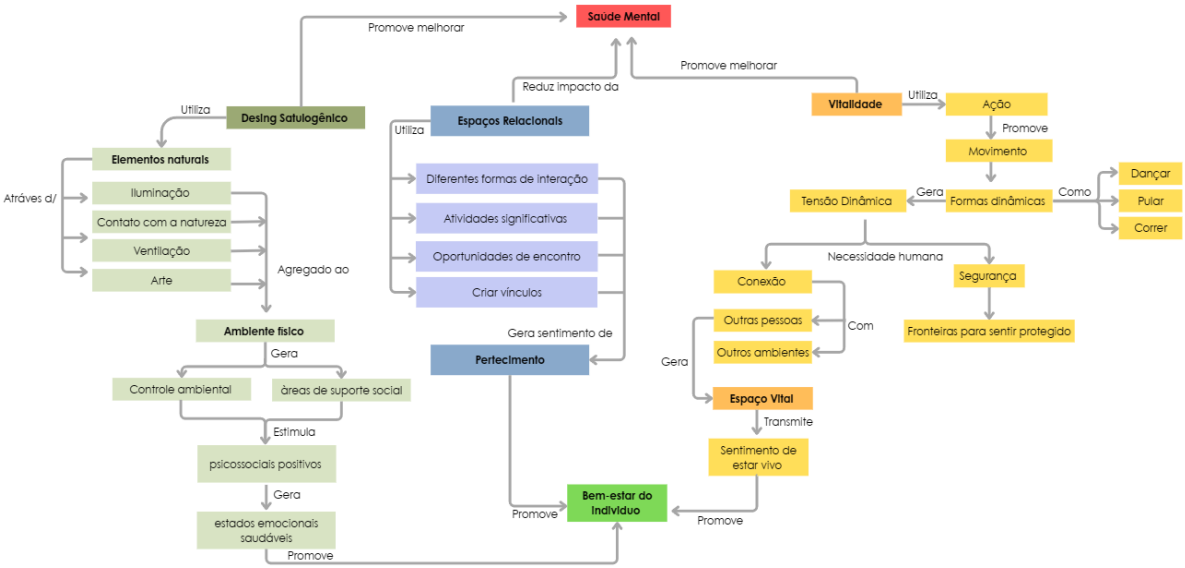
Vitalidade é citado como ‘sentir-se vivo’, surge tanto da experiência quanto da antecipação de estar em movimento, o que representa um senso de ação, possui formas dinâmicas com seus próprios padrões de atividade. Envolve tensão entre dois aspectos da vida, a necessidade de dividir o mundo de modo que possamos nos sentires fechados e seguros, e outra necessidade de se abrir e conectar relacionalmente com os outros e com o ambiente afim de promover o **espaço vital.** (SIMONSEN; BROWN; REAVEY, 2024).

Levando em consideração os conceitos apresentados, compreende-se que eles se articulam de forma complementar para promover o bem-estar do indivíduo a partir do ambiente em que está inserido. O **Design Salutogênico** oferece estratégias espaciais positivas; os **espaços relacionais** promovem o equilíbrio entre as áreas coletivas e individuais; e a **vitalidade** alinha a sensação de estar vivo. Juntos, esses conceitos se complementam e moldam os ambientes com elementos que favorecem estímulos positivos, a fim de não sobrecarregar a carga mental dos usuários. Assim, o ambiente físico deixa de ser um agente neutro e passa a atuar como um agente co-terapêutico, promovendo sentimentos favoráveis à melhora da saúde mental.

SÍNTESE INTERPRETATIVA

Diante os fatos apresentados, o aumento dos índices de pessoas diagnosticas com os transtornos de ansiedade e depressão, sobrecarga dos serviços públicos e limitações físicas, e a busca de compreender como o espaço físico influencia o comportamento. Os conceitos fundamentam que o ambiente pode favorecer a melhora dos quadros de saúde mental, através do Desing salutogênico, que oferece diretrizes ambientais restauradoras; os espaços relacionais agregam valor ao equilíbrio entre ambientes coletivos e privados; e a vitalidade atende a necessidade de movimento e interações seguras, visando promover espaços acolhedores e redução da fadiga mental. Dessa forma, os conceitos convergem com a pesquisa realizada, e permitem investigar a saúde mental de forma integrada, desde as esferas sociais, emocionais e experiência espacial. Assim a proposta do Centro de Saúde Mental parte como um equipamento co-terapêutico capaz de humanizar o atendimento e qualificar os espaços de cuidado.

DIAGRAMA CONCEITUAL



REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Previdência Social. Informe de Previdência Social. Brasília, DF, v. 37, n. 7, jul. 2025.

DILANI, Alan. **Building for Health**: Life Journey of a Kurdish Architect. [S. l.]: Amazon.com, 2018. ISBN 978-91-639-8019-0.

DILANI, Alan. The beneficial health outcomes of salutogenic design. **World Health Design**: Architecture, Culture, Technology, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 18–35, June 2015.

KOWALTOWSKI, Doris C. C. K.; MIKAMI, Silvia A.; PINA, G.; PRATA, Alessandra R.; FACCIN DE CAMARGO, Renata C. **Ambiente construído e comportamento humano: necessidade de uma metodologia**. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO (ENTAC), 8., 2000, Salvador. Anais [...]. Salvador: ANTAC, 2000. Disponível em: https://silo.tips/download/ambiente-construido-e-comportamento-humano-necessidade-de-uma-metodologia. Acesso em: 09 out. 2026.

ORBÁN, Ákos. **Neuroarquitetura: projetando para os sentidos e o inconsciente**. [S. l.]: TEDxBME, [s. d.]. 1 vídeo (11 min 58 s). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5sLHqaaK_d4. Acesso em: 14 out. 2026.

ORBÁN, Akos; VESSEL, Edward A. Bridging the translation gap in neuroarchitecture: a relational framework for architectural experience. Buildings, v. 16, n. 19, art. 3977, 2026. DOI: https://doi.org/10.3390/buildings16193977.

Silva R, Barbosa E, Nunes F. Infraestrutura dos CAPS e impactos na qualidade do cuidado. Rev Bras Saude Mater Infant. 2023;23(2):e20220156.
TINHOF, Melanie. **Por que a neuroarquitetura é o elo perdido para a saúde mental**. [S. l.]: TEDxTUWien, [s. d.]. 1 vídeo (7 min 12 s). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=nWFA3RPJkSM. Acesso em: 14 out. 2026.

SILVA, Ana Beatriz Barbosa. **Por Que a SAÚDE MENTAL Vai Piorar nos Próximos Anos?** Jota Jota Podcast #261. Entrevistador: Joel Jota. 13 jan. 2026. Vídeo (1h 38min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=G4PUkK6u66k. Acesso em: 3 out. 2026.

SIMONSEN, Thorben Peter Høj; BROWN, Steven D.; REAVEY, Paula. Vitality and nature in psychiatric spaces: Challenges and prospects for ‘healing architecture’ in the design of inpatient mental health environments. **Health & Place**, [S. l.], v. 85, art. 103169, p. 1–13, Jan. 2024. DOI: 10.1016/j.healthplace.2023.103169.

Souza L, Pereira R. Estrutura e organização dos serviços de saúde mental no Brasil. Saude Soc. 2023;28(4):e190321.
link:https://www.scielosp.org/article/csp/2021.v37n7/e00267720/

ULRICH, Roger S.; SIMONS, Robert F.; LOSITO, Barbara D.; FIORITO, Evelyn; MILES, Mark A.; ZELSON, Michael. Stress recovery during exposure to natural and

urban environments. Journal of Environmental Psychology, v. 11, n. 3, p. 201–230, 1991. DOI: https://doi.org/10.1016/S0272-4944(05)80184-7.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. World mental health report: transforming mental health for all. Geneva: World Health Organization, 2022. 296 p. ISBN 978-92-4-004933-8. Disponível em: https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338. Acesso em: 29 set. 2026.

WORSLEY, Joanne D.; HARRISON, Paula; CORCORAN, Rhiannon. Accommodation environments and student mental health in the UK: the role of relational spaces. **Journal of Mental Health**, [S. l.], v. 32, n. 1, p. 175–182, 2023. DOI: 10.1080/09638237.2021.1922648.

WORSLEY, Joanne D.; HARRISON, Paula; CORCORAN, Rhiannon. Accommodation environments and student mental health in the UK: the role of relational spaces. Journal of Mental Health, v. 32, n. 1, p. 175–182, 2023. DOI: https://doi.org/10.1080/09638237.2021.1922648.